

4-6. Emanuel.

Emanuel es un adolescente de 13 años, sano, con esquema de vacunación completo acorde a su edad y con rendimiento escolar satisfactorio. Acude a la consulta acompañado por sus padres por presentar agrandamiento de la mama izquierda de 2 cm, manifestando leve dolor a nivel de la mamila, cuadro que hizo su aparición aproximadamente una semana antes de la visita médica. Niega la existencia de otros síntomas. Más allá del hallazgo referido por Emanuel, el resto del examen físico no muestra datos a destacar. Los valores de presión arterial son normales. La evaluación de la maduración física arroja un estadio II-III de Tanner para genitales y vello pubiano.

Ante esta situación, Ud decide:

(Marque hasta 3 opciones)

- a) Derivar a cirugía mamaria.
- b) Informar que se trata de un evento transitorio.
- c) Mediar con antiestrógenos.
- d) ~~Solicitar mamografía.~~
- e) Solicitar ecografía mamaria.
- f) Continuar con los controles habituales.
- g) Solicitar determinación de LH, FSH y testosterona.
- h) Mediar con ibuprofeno en caso de dolor.

5-1. Mía.

Usted se encuentra de guardia en un sanatorio de CABA y llega una paciente que ha sido controlada adecuadamente durante el embarazo confirmándose que el mismo se encuentra a término, según última ecografía: 40 semanas de gestación.

La madre presenta un buen trabajo de parto no observándose situaciones de riesgo.

Luego del nacimiento de Mía, ¿cuáles son las primeras acciones a realizar?

(Marque hasta 3 opciones)

- a) Clamper inmediatamente el cordón umbilical.
- b) Evaluar los parámetros del test de Apgar.
- c) Realizar el examen clínico del recién nacido.
- d) Aplicar la vacuna BCG.
- e) Colocar al recién nacido en contacto con su madre.
- f) Realizar la pesquisa neonatal.
- g) Aplicar la vacuna contra la hepatitis B y la vitamina K.
- h) Dejar al recién nacido en observación en Neonatología.

Ud. ha finalizado el examen, por favor pase las respuestas a la grilla.

3-5. Livio.

Livio de 1 mes de vida es llevado a consulta por presentar desde hace 10 días, episodios de irritabilidad y llanto inconsolable.

La madre refiere estar desesperada, ya que, desde hace una semana al atardecer o noche, comienza con llanto repentino, diferente al del resto de día, se retuerce, flexiona las piernas hacia el abdomen, rechaza el pecho y no puede calmarlo ni en brazos, ni en la cuna y que después de un par de horas o tres se calma solo. Estos episodios ocurren casi a diario y no parecen relacionarse con el sueño ni con el hambre.

Se alimenta con lactancia materna exclusiva a demanda, aunque se cuestiona continuar con la misma porque piensa que su leche no es buena y le está haciendo daño al bebé.

Hasta ahora no ha tenido vómitos. Efectúa una deposición grumosa, de color amarillo oro luego de cada toma y la emisión de orina es normal.

Antecedentes personales: embarazo controlado y normal. Parto eutócico a término. Peso al nacimiento de 2.900 gr. Periodo neonatal inmediato sin complicaciones. Pruebas metabólicas normales

Examen físico:

Niño en buen estado general, bien hidratado y perfundido. Reactivo y vital. Afebril.

Peso: 3500 gramos. Talla: 51 cm.

No se observan exantemas en la piel.

Auscultación cardíaca y pulmonar de características normales.

Abdomen blando, depresible, indoloro a la palpación, sin masas ni visceromegalias.

Resto del examen normal.

De acuerdo a los datos presentados, ¿cuáles son las conductas más adecuadas?
(Marque hasta 3 opciones)

- ☐ a) Informar a los padres que se trata de un proceso benigno.
- ☐ b) Solicitar interconsulta con gastroenterología infantil.
- ☒ c) Continuar con lactancia materna exclusiva.
- ☒ d) Efectuar apoyo emocional al grupo familiar.
- ☐ e) Indicar simeticona reglada durante 2 semanas.
- ☐ f) Indicar a la madre dieta libre de proteína de leche de vaca.
- ☐ g) Solicitar interconsulta con Neurología infantil.
- ☐ h) Solicitar radiografía directa de abdomen en posición erecta.

3-1. Gaspar.

Ud atiende en un Centro de salud a Gaspar, de 9 años de edad. Su madre refiere que desde hace 6 meses padece dolor abdominal de modo intermitente y por el que concurrió a consulta en alguna oportunidad anterior. En los últimos cuatro meses, el dolor ha comenzado a despertarlo por la noche con cierta frecuencia.

Hace dos meses concurrió por un episodio de dolor y fue medicado con un antiparasitario de modo empírico y el dolor cedió, aunque reapareció posteriormente.

Es un poco desordenado con las comidas, pero come menos que antes y parece estar cansado. Su rendimiento escolar siempre fue bueno, pero su maestra los ha llamado más de una vez porque Gaspar decía que le dolía la panza.

Examen físico:

Niño en regular estado general, impresiona adelgazado. Palidez moderada de piel y mucosas. Se observan algunas aftas en cavidad oral.

Peso 23 kg. (Pc 10) Talla 131 cm (Pc 25-50), temperatura 37,6 °C, frecuencia cardíaca 120 por minuto. Frecuencia respiratoria 28 por minuto Tensión arterial: 115/70 mmHg.

Conjuntivas algo pálidas. Auscultación cardiopulmonar normal.

Abdomen blando, discretamente tenso. Dolor intenso a la palpación profunda en flanco derecho. Signos peritoneales negativos. No se palpan visceromegalias. Examen neurológico normal.

Con los datos disponibles, ¿cuáles son las conductas más adecuadas? (Marque hasta tres opciones).

- a) Consultar lo antes posible a un gastroenterólogo infantil.
- ☒ b) Investigar su relación con su maestra y sus compañeros de escuela.
- ☒ c) Efectuar una interconsulta a psicología infantil.
- d) Indicar dieta pobre en residuos por 7 días y citar nuevamente a control.
- ☒ e) Solicitar ecografía abdominal.
- f) Solicitar hemograma, eritrosedimentación, proteinograma.
- g) Solicitar endoscopia digestiva alta.
- h) Indicar omeprazol durante ocho semanas y citar luego a control.

3-2. Juan José.

Juan José, de 5 años, acude a la clínica por presentar cojera desde hace 2 días. Su madre refiere que anoche lo notó calentito cuando lo acostó, pero no le tomó la temperatura. Hoy ha estado menos activo que de costumbre y ha tenido poco apetito.

Sus vacunas están actualizadas según calendario. No tiene alergias conocidas.

La madre afirma que lo llevó a urgencias hace 15 días por fiebre, dolor de oído, ojos llorosos y tos. Le diagnosticaron una infección de oído y una infección viral de las vías respiratorias superiores. No hay antecedentes de traumatismo.

Examen físico:

Peso 18 kg. Temperatura 38,5°C, Frecuencia cardíaca 100 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria 30 respiraciones por minuto. Presión arterial 105/66 mm Hg.

El niño está acostado, inmóvil pero alerta y receptivo. Su piel no muestra eritema ni erupciones.

Reflejos tendinosos profundos de la pierna derecha positivos. No se pueden determinar en la pierna izquierda debido al dolor.

Cuando se le pide que localice su dolor, señala la ingle y la parte superior del muslo. Su cadera izquierda se mantiene flexionada, en abducción y en rotación externa. Se resiste a ser examinado al intentar mover la cadera izquierda. La ecografía de cadera que muestra líquido articular particulado. El hemograma muestra leucocitosis con neutrofilia y la PCR está elevada.

¿Cuáles son las conductas más adecuadas? (Marque hasta 3 opciones).

- ☒ a) Indicar clindamicina E.V.
- b) Indicar trimetoprima-sulfametoxazol por V.O.
- ☒ c) Solicitar centellograma con tecnecio-99.
- d) Solicitar exploración quirúrgica de cadera.
- e) Indicar reposo, AINES y control en 24 horas.
- f) Indicar tracción de partes blandas.
- ☒ g) Internar y solicitar hemocultivos.
- h) Solicitar resonancia magnética de cadera.

3-6. Angel.

Ángel es un niño de 3 años. Su mamá Patricia consulta porque: "No habla nada, solamente dice mamá, papá y agua. Pero entiende todo. Cuando le pido que traiga algún juguete, él lo hace sin dificultad. A veces parece un mimo hace el gesto de que toma del vaso o pone cara de olor feo cuando necesita que le cambien el pañal". Un niño tímido con los adultos extraños, pero le llaman la atención los otros niños y se acerca a ellos.

Antecedentes personales: Embarazo controlado. Parto y postparto normal. Peso de nacimiento 3.200 gramos, longitud corporal 50 cm. Alta conjunta a las 48 horas. Otoemisiones acústicas normales. Lactancia materna durante 6 meses, actualmente alimentación completa y variada. Inmunizaciones completas.

Se sentó a los 6 meses, caminó al año y aún usa pañales.

No concurre a jardín maternal. Lo cuida su mamá con ayuda de los abuelos.

Antecedentes patológicos: Dos episodios de catarro de vías aéreas superiores, una otitis media aguda y una gastroenteritis.

Antecedentes familiares: Padre de 27 años empleado administrativo municipal no registrado; madre de 24 años con trabajos informales. Ángel tiene un hermano mayor con el que juega mucho con los autitos.

En el conurbano bonaerense viven en una casa de material con dos dormitorios.

Tienen agua de pozo y eliminan excretas por pozo ciego.

Examen físico y neurológico normales. Durante la entrevista Ángel siempre mira a los ojos de quienes le hablan.

¿Cuáles son las conductas iniciales más adecuadas en función de su hipótesis diagnóstica? (Marque hasta tres opciones).

- a) Explicar a Patricia que el desarrollo del lenguaje de Ángel es normal.
- ☒ b) Sugerir la lectura de cuentos para estimular la incorporación de palabras.
- ☒ c) Indicar nombrar los objetos que se le van a dar.
- d) Solicitar valoración por fonoaudiología.
- e) Solicitar tratamiento neurolingüístico.
- ☒ f) Citar nuevamente a control ambulatorio en tres meses.
- g) Citar en 48 horas para tomar una lista de chequeo para autismo en deambuladores.
- h) Solicitar audiometría por juego.

4-1. Lorenzo.

Lorenzo de 2 años es traído a la guardia por sus padres por presentar edema bipalpebral en ojo derecho y fiebre de $38,5^{\circ}\text{C}$ de 36 horas de evolución, presenta además regular actitud alimentaria y está menos activo. La semana anterior tuvo rinorrea mucosa, estornudos y tos, consultó en el centro barrial y le indicaron difenhidramina oral. Los padres le comentan que Lorenzo no ha sufrido traumatismos ni presentó picaduras de insectos en el rostro. Como antecedentes a destacar surgen 2 episodios de broncoobstrucción en el último año.

Examen físico: niño decaído. Febril ($38,9^{\circ}\text{C}$), FC 120 latidos x min, FR 24 respiraciones por minuto, TA 90/50 mmHg, hemodinámicamente compensado.

Presenta tumefacción y eritema en ambos párpados de ojo derecho que limitan su apertura. No presenta quemosis ni exoftalmos evidente. Movimiento ocular derecho y visión de difícil evaluación por el dolor.

Indique cuáles son las conductas iniciales más adecuadas. (Marque hasta 3 opciones).

- a) Indicar gotas oftálmicas con eritromicina.
- ☒ b) Solicitar TAC de órbita y macizo facial.
- c) Colocar compresas frías y lavados con solución estéril.
- d) Indicar antihistamínicos y corticoides orales y control en 48 horas.
- ☒ e) Indica internación para tratamiento antibióticos endovenosos y analgésicos.
- f) Indica amoxicilina-clavulánico vía oral 14 días.
- ☒ g) Solicitar hemograma, dos hemocultivos y reactantes de fase aguda.
- h) Solicitar radiografía de cavum y senos paranasales.

1-3. Roxana.

Roxana, de 6 años de edad, es llevada a consulta por presentar desde hace 5 días, lesiones en piel de miembros inferiores y dolor abdominal periumbilical de 48 horas de evolución. Es la primera hija de una pareja de clase media del barrio de Balvanera de CABA. Sus padres refieren, asimismo, que se ha quejado de dolor en las rodillas y los tobillos durante los últimos tres días y desde esta mañana tiene dificultades para caminar.

Tiene buena actitud alimentaria y tolerancia oral. La diuresis está conservada y las deposiciones son normales.

Examen físico:

Abdomen blando, depresible. Discreto dolor a la palpación. No se palpan visceromegalias.

Se encuentra afebril.

Frecuencia cardíaca de 80 latidos/minuto. Frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto. Tensión arterial 108/60 mm Hg.

Se observa tumefacción en ambos tobillos y exantema eritematoso que no desaparece a la vitropresión, sobre elevada, en las extremidades inferiores.

No refiere otros antecedentes de importancia. Presenta vacunas completas para la edad.

Los resultados de estudios complementarios son los siguientes:

Hemograma: hemoglobina: 12 g/dl, recuento de leucocitos: 8.200/mm³ (neutrófilos 50% linfocitos 45%, monocitos 5%), plaquetas: 180.000/mm³. Eritrosedimentación: 20 mm/1ra hora.

Tiempo de protrombina: 85%, APTT: 38 segundos.

Uremia: 30 mg/dl, creatinina: 0,6 mg/dl.

Orina completa: densidad: 1.020, pH 5,5, proteínas: ++, hemoglobinuria: ++, leucocitos: 10/campo, hematíes: 20/campo.

Con la información disponible, las conductas más adecuadas son:

(Marque hasta 3 opciones).

- a) Indicar reposo y control ambulatorio en 48 horas.
- b) Indicar gammaglobulinas a 2 gramos/kilo.
- ☒ c) Indicar internación.
- d) Indicar antiinflamatorios no esteroideos.
- ☒ e) Solicitar orina completa en 48 horas.
- ☒ f) Indicar corticoides por vía oral.
- g) Indicar furosemina vía oral.
- h) Indicar biopsia renal.

1-4. Juan.

Juan de 6 años concurre a la guardia por presentar fiebre de 38,5°C de 4 días de evolución y odinofagia progresiva. Refiere astenia e inapetencia. Consultó a un centro de salud cercano a su domicilio en las primeras 24 horas de los síntomas donde le realizaron un test rápido para búsqueda de estreptococo en fauces que fue negativo.

Al examen físico se observa al niño decaído, con fauces eritematosas, presenta exudado blanquecino en ambas amígdalas, halitosis, voz nasal y edema sutil de párpados. Adenopatías submaxilares, laterocervicales y cervicales posteriores, dolorosas. Presenta un exantema eritematoso generalizado. Como antecedentes de relevancia presentó escarlatina a los 4 años y varicela el año pasado.

Abdomen blando, depresible, indoloro, no se palpan visceromegalias.

No refiere otros antecedentes a destacar. Presenta vacunas completas documentadas.

En relación al cuadro clínico presentado, ¿cuál es la conducta inicial más apropiada? (Puede marcar hasta 3 opciones):

- ~~a) Solicitar consulta con ORL.~~
- ~~b) Solicitar hemograma y hepatograma.~~
- ☒ c) Indicar tratamiento antibiótico con Penicilina V por 10 días.
- ☒ d) Solicitar ecografía abdominal.
- ☒ e) Repetir test rápido, cultivo de fauces y solicitar Monotest.
- f) Radiografía de senos paranasales.
- g) Ante mejoría clínica retomar las actividades a las 24hs.
- ☒ h) Indicar reposo y control ambulatorio.

no e
usual, ne?

2-5. Felicitas.

Felicitas, de 8 años, concurre al hospital cercano a su domicilio.

Sus padres están preocupados porque ella es bastante más pequeña que los compañeros de su clase.

Es una niña nacida luego de un embarazo de término y parto eutócico.

Peso y talla al nacer: 3.150 gramos y 50,8 cm.

Hasta ahora no ha tenido antecedentes de enfermedad significativa.

Hace varios meses, sus padres habían consultado al pediatra por constipación, presentando deposiciones cada 4 o 5 días.

Concurre a 3er grado de escuela primaria y su rendimiento escolar es adecuado.

Según lo observado en registros previos su talla se ubicó en percentilo 25 hasta los 5 años y desde entonces descendió por debajo del percentilo 5, en el que actualmente se encuentra.

El año pasado, creció 2,5 cm. Sus padres y su hermano de 10 años están en el percentilo 75.

Examen físico:

Peso: 25,500 kg. (Pc 50) Talla: 115 cm (Pc 3).

Frecuencia cardíaca: 60 latidos por minuto. Presión arterial: 96/64 mm Hg.

Auscultación cardiopulmonar normal. Examen neurológico normal. No hay rasgos dismórficos.

Piel seca, especialmente sobre las superficies de extensión.

Abdomen globuloso, con materia fecal en colon descendente.

De acuerdo a los datos presentados, ¿cuáles son las conductas más adecuadas?

(Marque hasta 3 opciones)

- a) Solicitar IgA antitransglutaminasa.
- b) Solicitar T4 libre, TSH.
- c) Solicitar determinación de hormona de crecimiento.
- d) Solicitar autoanticuerpos tiroideos.
- e) Solicitar radiografía de silla turca.
- f) Solicitar radiografía de carpo.
- g) Solicitar resonancia magnética de cerebro.
- h) Solicitar consulta con genética.

2-6. Natalia.

Natalia, de 5 años, concurre por presentar dolor en sus manos y piernas durante las últimas 6 a 8 semanas, que empeora por la mañana.

Sus padres refieren que tiene fiebre desde hace más de tres semanas y un exantema que aparece y desaparece.

Ellos no han notado hinchazón en las articulaciones, pero en ocasiones ven que cojea por la mañana hasta después del desayuno. Le han administrado ibuprofeno y el dolor se atenúa parcialmente.

Hasta ahora ha estado comiendo y bebiendo normalmente.

No hay antecedentes recientes de dolor de garganta.

Examen físico:

Niña en regular estado general, impresiona enferma.

Palidez de piel y mucosas.

Temperatura axilar: 39°C. Frecuencia cardíaca 120 latidos por minuto.

Se observa rash maculopapular no pruriginoso en axilas, abdomen y tronco.

Signos de inflamación de codo izquierdo, ambos carpos, segunda articulación metacarpofalángica derecha, ambas rodillas, tobillo izquierdo, con dolor y limitación en la movilidad articular. Se palpan múltiples adenopatías indoloras y elásticas.

De acuerdo a los datos presentados, ¿cuáles son las conductas más adecuadas?

(Marque hasta 3 opciones).

- a) Solicitar hemograma, eritrosedimentación y PCR.
- b) Solicitar Antiestreptolisina O y exudado de fauces.
- c) Solicitar punción diagnóstica de alguna de las grandes articulaciones.
- d) Solicitar ecocardiograma y ECG.
- e) Solicitar interconsulta con traumatología infantil.
- f) Solicitar interconsulta con reumatología infantil.
- g) Solicitar interconsulta con cardiología infantil.
- h) Solicitar interconsulta con oftalmología infantil.

1-5. Lucas.

Sofía, de 20 años, concurre con su hijo Lucas, de 4 meses, al centro de salud donde usted atiende habitualmente para el control en salud.

Como antecedentes perinatales, nació de un parto vaginal, espontáneo, en cefálica con un peso al nacer de 3.200 gramos, edad gestacional de 38 semanas y Apgar 9/10. La madre cursó un embarazo sin interurrencias y con los controles habituales. Pesquisas neonatales metabólicas, y auditivas normales.

Se alimenta con leche materna exclusiva.

En la anamnesis refiere que Lucas fija y sigue con la mirada. Toma objetos con la mano y se lleva la mano a la boca. Sonríe y balbucea.

Al examen físico luce en buen estado general, conectado. Al tratar de incorporarlo tomándolo de las manos acompaña con la cabeza. En decúbito ventral no logra balconeo. No logra trípode ni sedestación. Intenta rolar pero no lo consigue.

Buen progreso ponderal.

Peso y talla en percentilos 50, perímetro cefálico en percentilo 25-50

Resto del examen físico dentro de límites normales.

Ante esta consulta, además de indicarle las vacunas correspondientes, ¿cuáles son las conductas iniciales más adecuadas?

(marque hasta 3 opciones)

- a) Indicar sulfato ferroso a 1 mg/kilo/día y vitamina D 400 UI/día.
- b) Indicar vitamina C 100 mg/día.
- c) Reforzar pautas de estimulación por los cuidadores y control en un mes.
- d) Solicitar tratamiento con estimulación temprana.
- e) Comentar a la madre que la ausencia de trípode es preocupante.
- f) Explicarle que es esperable que haya diferencias entre las distintas áreas de desarrollo.
- g) Solicitar ecografía de cerebro.
- h) Indicar comienzo de alimentación con semisólidos.

1-6. Rodrigo.

Consultan a su consultorio la madre y la tía de Rodrigo, de 3 meses de vida. Consultan porque durante el último mes vomita la leche luego de algunas de las tomas. Tini, su madre, está muy preocupada porque hasta el comienzo de los vómitos, el niño no había presentado ningún problema.

No refieren fiebre, mantiene muy buena actitud alimentaria.

De un embarazo deseado y controlado, el parto había sido por vía vaginal con presentación cefálica a las 38 semanas de edad gestacional. Pesó 3.300 gramos y

el puntaje de Apgar fue vigoroso, según la libreta sanitaria. Alta conjunta a las 48 horas. En el último control de los 2 meses de vida su desarrollo pondoestatural había sido adecuado. Se alimenta con lactancia materna y es muy "glotón".

Al examen físico: Peso 6.500 gramos (pc 50-75), talla: 62 cm (pc 50-75). Afebril. Normohidratado. Examen cardiovascular y respiratorio normal. Abdomen blando, depresible e indoloro. Se constata buena succión y actitud alimentaria. En el momento de la palpación abdominal presenta regurgitación de leche.

Teniendo en cuenta sus hallazgos y de acuerdo a su diagnóstico presuntivo inicial, ¿Cuáles de las siguientes son las conductas más adecuadas?

(Marque hasta 3 opciones).

- a) Solicitar phmetría.
- b) Aconseja elevar la cabecera de la cuna.
- c) Indicar sucralfato y esomeprazol.
- d) Solicitar ecografía abdominal.
- e) Aconseja disminuir el tiempo de las tomas y aumentar la frecuencia.
- f) Seriada esófago-gastro-duodenal.
- g) Citar a control en un mes.
- h) Solicitar orina completa y urocultivo al acecho.

2-3. Celina.

Celina, de 3 años es llevada a consulta por sus padres por presentar desde hace tres meses, deposiciones blandas, fétidas, abundantes, acompañadas de dolor abdominal intermitente.

Los padres refieren que desde hace un tiempo está quejosa, irritable, y no quiere comer como de costumbre. Siempre tiene sueño y parece cansada.

Comentan también que Celina tiene mucha panza y que está más delgada.

Examen físico:

Niña en regular estado general. Mucosas levemente pálidas, húmedas. Piel seca, uñas con estrías. Cabello que se desprende con cierta facilidad.

Peso: 10 kg (percentilo 10). Talla 93 cm (percentilo 25).

Frecuencia cardíaca: 110 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria: 25 respiraciones por minuto.

Se observa un hematoma de discreto tamaño en zona cercana a la axila derecha.

Abdomen globuloso, timpánico en hemicólon superior y mate en hemicólon inferior.

Ruidos hidroaéreos presentes.

De acuerdo a los datos presentados, las conductas iniciales a seguir incluyen:
(Marque hasta 3 opciones).

- a) Iniciar régimen libre de gluten.
- b) Solicitar IgA antitransglutaminasa.
- c) Solicitar interconsulta con hematología.
- ☒ d) Solicitar coagulograma.
- e) Indicar suplementos de hierro y vitaminas durante 2 semanas y citar a control.
- ☒ f) Determinar niveles plasmáticos de las vitaminas liposolubles.
- ☒ g) Solicitar parasitológico seriado.
- h) Indicar dieta hipograsa e hipofermentativa.

2-4. Julio.

Concurren a la guardia donde usted se desempeña en un hospital del conurbano, los padres con Julio, de 4 años, por fiebre y úlceras en boca. Al interrogarlos, refieren que el niño había presentado fiebre elevada el día anterior y que al día siguiente aparecieron vesículas dolorosas en la mucosa bucal, con rechazo a la ingesta de alimentos sólidos y calientes. Julio se mostraba algo irritable y poco colaborador.

Inmunizaciones completas para su edad. Desarrollo madurativo sin particularidades.

En el examen físico el niño luce en buen estado general, con un palito de helado de frutilla en su mano derecha. Frecuencia cardíaca: 110 por minuto. TA: 95/60 mmHg. Frecuencia respiratoria: 18 por minuto. Temperatura axilar: 37 °C. Presenta vesículas dispersas periorales.

El examen intraoral constató la presencia de úlceras de 1-3 mm de diámetro, tapizadas igualmente por una membrana blanquecina y rodeadas de un halo eritematoso, en paladar duro y blando, mucosa gingival eritematosa y, dolorosa. Además, presenta lesiones máculo pápulo eritematosas y dolorosas en palmas y plantas.

La madre comenta que en el jardín donde asiste hubo compañeros con los mismos síntomas.

¿Cuáles son las conductas más adecuadas?

(Marque hasta tres opciones).

- ☒ a) Indicar dieta blanda y fría.
- ☒ b) Explicar a la familia que este cuadro deja inmunidad permanente.
- ☒ c) Podrá regresar al jardín cuando se sienta bien.
- d) Indicar un baño con clorhexidina durante 3 días.
- e) Indicar aciclovir 100 mg/k/d VO durante 7 días.
- f) Indicar cefalexina 100 mg/k/día VO durante 7 días.
- g) Explicar a la familia que el cuadro puede repetirse.
- h) El alta la tendrá al séptimo día de aparición de las lesiones.

3-3. Nina

Nina de 7 semanas de vida es llevada a la guardia por sus padres porque desde hace 2 días, notan que no mueve las extremidades superiores y llora ante la movilización pasiva de las mismas. Nacida de embarazo no controlado y parto domiciliario.

Exploración física: buen desarrollo pondoestatural y madurativo. Ambas extremidades superiores permanecían sin movimientos espontáneos y su movilización es dolorosa. Palidez de piel y mucosas, rinitis serosa, exantema máculopapuloso rojo-anaranjado no confluyente en tronco, segmentos distales de las extremidades, palmas y plantas.

Hepatomegalia y esplenomegalia de 5 y 3 cm respectivamente por debajo del reborde costal.

Enantema palatino de máculas eritematosas con ulceración central.

En función de la principal sospecha diagnóstica, ¿cuáles son las conductas iniciales más adecuadas? (Marque hasta 3 opciones)

- ☒ a) Internar a Nina y solicitar radiografías de huesos largos y ecografía abdominal
- ☐ b) Solicitar Rx de ambos brazos y control ambulatorio con los resultados.
- ☐ c) Indicar cefotaxime y ampicilina endovenosos.
- ☐ d) Solicitar tomografía abdominal con contraste endovenoso.
- ☒ e) Solicitar serologías: CMV, Herpes y rubéola pareadas madre e hija.
- ☒ f) Solicitar VDRL (madre e hija).
- ☐ g) Solicitar resonancia magnética de cerebro.
- ☐ h) Indicar punción lumbar (VDRL y citoquímico de LCR)

3-4. Lautaro

Lautaro de 9 meses de edad, es llevado al servicio de emergencias por presentar desde hace 8 horas, llanto intenso en forma intermitente.

Entre cada uno de estos episodios parece estar calmo y con ganas de jugar hasta que los síntomas reaparecen. En las últimas horas, los padres refieren que Lautaro está cada vez más decaído y tiene mucho sueño. También ha presentado dos vómitos alimentarios. Ha tenido dos deposiciones de consistencia normal con algo de mucosidad. La madre niega haber visto sangre en las mismas.

Examen físico:

Niño alerta e irritable durante el examen. Temperatura axilar: 37.3°C. Frecuencia cardíaca 120 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria: 28 respiraciones por minuto. Auscultación cardiopulmonar dentro de límites normales.

Aumento de tensión y dolor al palpar el hemiabdomen derecho.

De acuerdo a los datos presentados, ¿Cuáles son las conductas más adecuadas? (Marque hasta 3 opciones)

- ☒ a) Tomar 2 muestras para hemocultivo.
- ☐ b) Indicar líquidos fraccionados por vía oral y citar en 12 horas.
- ☐ c) Solicitar interconsulta con Infectología infantil.
- ☐ d) Solicitar interconsulta con cirugía infantil.
- ☒ e) Solicitar ecografía abdominal.
- ☐ f) Indicar tratamiento empírico inicial con ceftriaxona por vía parenteral.
- ☒ g) Colocar vía de acceso endovenoso y ayuno.
- ☐ h) Solicitar colon por enema con contraste baritado.

2-1. Mauricio.

Concurren a su consultorio los padres de Mauricio, de 16 años, que regresó de un viaje escolar a Bariloche hace 3 días. El adolescente relata que hace 48 horas presenta fiebre (temperatura axilar 38-38,5°C), decaimiento, inapetencia y cefalea intensa y que no cede con paracetamol por vía oral. Relata que en su viaje compartieron habitación con otros 3 compañeros, uno de los cuales, tiene iguales manifestaciones clínicas.

Mauricio no presenta antecedentes patológicos de importancia. Vive con sus padres y un hermano de 6 años. Vacunación completa hasta los 6 años según calendario oficial.

Examen físico: Frecuencia cardíaca 96 por minuto. TA 110/65 mm Hg.

Frecuencia respiratoria 14 por minuto. Oximetría con aire ambiental 97 %.

Temperatura axilar 37°C. Luce en buen estado general, colaborador sin lesiones en piel.

Dos ruidos en 4 focos con silencios libres; pulsos periféricos presentes y simétricos. Buena entrada de aire bilateral, sin ruidos agregados.

Abdomen blando, depresible e indoloro. Pares craneales sin particularidades, trofismo, tono y fuerza muscular conservados, reflejos osteotendinosos presentes. Signo de Kernig positivo.

Además de solicitar hemograma y reactantes de fase aguda. ¿Cuáles son las conductas iniciales en función de su hipótesis diagnóstica?

(Marque hasta 3 opciones).

- a) Solicitar tomografía de cerebro.
- b) Indicar ceftriaxona 4 gramos/día EV.
- ☒ c) Obtener dos hemocultivos de sangre periférica.
- ☒ d) Indicar examen citológico y cultivo de LCR.
- ☒ e) Indicar ceftriaxone 250 mg IM dosis única.
- f) Indicar rifampicina VO a 20 mg/kg durante 48 horas.
- g) Indicar aciclovir EV.
- ☒ h) Solicitar serología para dengue.

No 3-50 steps / nurse

Mauricio 16 años

Microorg:
step y Neisseria
GRAM O

DCron Inespe?

2-2. Mauro.

Mauro, de 1 año y 8 meses, es traído a consulta por sus padres por presentar deposiciones blandas desde hace más de un mes. *D. Cron*

La mamá refiere que su hijo tiene deposiciones muy abundantes, 6-7 diarias, que sobrepasan con frecuencia los pañales. En ocasiones se observan restos de alimentos no digeridos en las mismas. No ha presentado fiebre ni vómitos. El ánimo está conservado y su apetito es el habitual. Consume diariamente leche de vaca entera y alimentos variados.

Desde que aparecieron los síntomas, sus padres le ofrecen más agua y jugos que de costumbre porque temen que se deshidrate. No notan que haya adelgazado.

Hace 15 días consultaron en un centro de salud por este motivo y le indicaron dieta con pocos residuos, abundantes líquidos y un jarabe a base de hidróxido de bismuto, medidas que atenuaron los síntomas por unos pocos días.

Examen físico:

Niño en buen estado general. Peso: 11.500 gramos. (Pc 25-50). Talla 83 cm (Pc 25-50)

Normohidratado. Auscultación cardiopulmonar dentro de límites normales.

Abdomen levemente globuloso, indoloro a la palpación. Hígado a 1 cm bajo el reborde costal.

Bazo no se palpa.

Con los datos presentados, las acciones más adecuadas en lo inmediato son:

(Marque hasta tres opciones).

- ☒ a) Reducir la ingesta de alimentos ricos en almidón.
- ☒ b) Aumentar el contenido graso en la dieta diaria.
- c) Administrar loperamida luego de cada deposición diarreica durante 72 horas.
- d) Moderar el volumen de ingesta de líquidos.
- ☒ e) Evitar la ingesta de bebidas azucaradas.
- f) Solicitar investigación de shiga toxina en materia fecal.
- ☒ g) Solicitar IgA antitransglutaminasa.
- ☒ h) Indicar leche con bajo contenido de lactosa.

1-1. María José

Niña de 5 años que consulta acompañada por su madre alarmada por la presencia recurrente de prurito vulvar y flujo que mancha la ropa interior, con rascado muy frecuente del área vulvar y anal. Recibió tratamiento local con té de malva en dos oportunidades. La niña no presenta antecedentes personales de importancia. La madre fue tratada recientemente con óvulos vaginales. La niña concurre a un nuevo jardín desde este año con dificultades en la adaptación y realiza colecho eventual con los padres.

Al examen presenta: Enrojecimiento de labios mayores, hiperemia de labios menores e introito, himen congestivo y se observa flujo vaginal blanquecino no maloliente. Además se observan lesiones de rascado en el área perianal.

De acuerdo a su diagnóstico presuntivo, ¿cuáles son las conductas iniciales correctas?
(Marque hasta 3 opciones)

- ☐ a) Aconsejar uso de ropa interior de algodón y evitar ropa ajustada.
- ☐ b) Solicitar cultivo de flujo vaginal.
- ☒ c) Indicar crema local con Clotrimazol.
- ☐ d) Realizar vaginoscopia.
- ☐ e) Solicitar Test de Graham.
- ☐ f) Solicitar ecografía ginecológica.
- ☐ g) Tratamiento local con solución astringente.
- ☐ h) Solicitar interconsulta con ginecología infanto-juvenil.

1-2. Bautista

Concurren a la guardia de un hospital general de alta complejidad del conurbano bonaerense, Laura y Martín con su hijo Bautista de 8 meses y medio de edad por presentar un episodio paroxístico de flexo-extensión de hemicuerpo derecho de menos de 3 minutos de duración. Sus padres relatan que el episodio sucedió hace una hora.

Durante las últimas 48hs presentó fiebre de 38-38.5°C, rechazo del alimento e irritabilidad. Diuresis disminuida y catarsis conservada.

Bautista es el primer hijo, sin antecedentes a destacar. Vacunas: BCG, Hepatitis B, 2 dosis de vacuna conjugada 13 valente para neumococo, 2 dosis pentavalente, 2 dosis de polio (IPV) y 2 dosis de rotavirus, 1 dosis de meningococo ACYW135.

Examen físico: paciente en regular estado general, somnoliento, con respuesta a estímulos, pupilas isocóricas y reactivas, sin signos de foco, febril 38,2°C. Frecuencia cardíaca: 120 latidos por minuto, TA: 90/55 mmHG, frecuencia respiratoria 30 por minuto, relleno capilar 2 segundos. Pulsos periféricos presentes y simétricos. Rinorrea acuosa en ambas narinas. Abdomen normal. Resto del examen sin particularidades.

Además de colocar monitor, vía periférica e indicar antitérmico y estudios de laboratorio iniciales, ¿cuáles son las conductas iniciales más adecuadas? (Marque hasta 3 opciones).

- ☐ a) Indicar lorazepam EV.
- ☐ b) Observar en guardia durante 6 h y según evolución control ambulatorio.
- ☒ c) Solicitar orina completa y urocultivo al acecho.
- ☒ d) Solicitar estudio virológico de líquido cefalorraquídeo.
- ☒ e) Indicar ceftriaxona y dexametasona luego de haber realizado una punción lumbar.
- ☐ f) Indicar interconsulta urgente con neurología infantil.
- ☐ g) Indicar electroencefalograma de urgencia.
- ☐ h) Indicar aciclovir EV y tomografía de cerebro.

4-4. Violeta.

Violeta, de 3 años de edad, es traída por sus padres al servicio de emergencias.

La madre relata que, al salir de su casa, cuando bajaban las escaleras, su hija tropezó y entonces le tiró del brazo para que no se cayera.

A partir de allí, la niña se encuentra molesta, llora por momentos y no mueve el brazo.

Examen físico:

Niña en buen estado general. Sostiene el brazo izquierdo con la mano derecha a la altura del codo.

Dolor leve que empeora al intentar movilizar el brazo afectado.

No puede girar la muñeca ni tomar objeto alguno.

Ante esta situación, Ud. explica a sus padres que: **(Marque hasta 3 opciones)**

- ☒ a) Se trata de una situación frecuente que no reviste gravedad.
- ☒ b) Con una simple maniobra, el codo volverá a moverse normalmente en pocos minutos.
- ☐ c) La reiteración del episodio es muy poco probable.
- ☐ d) Es necesario inmovilizar el brazo con férula por 7 días.
- ☒ e) No es necesario efectuar radiografías.
- ☐ f) Es conveniente realizar estudios de imágenes.
- ☐ g) Debe efectuar controles en el servicio de Traumatología infantil.
- ☐ h) Luego del alta, debe realizar tratamiento kinésico.

4-5. Maira.

Usted se encuentra de guardia en el Servicio de Emergencias del Hospital de su ciudad, cuando a las 4 AM ingresa Maira, una adolescente de 14 años, traída por sus padres, con disminución del nivel de conciencia, somnolencia, vómitos, ataxia y disartria. Sin signos meníngeos ni de foco motor. Los padres relatan que su hija estaba en una fiesta con sus amigos quienes refirieron que tomaron bebidas alcohólicas, y negaron el consumo de otras sustancias.

La paciente se encuentra con una temperatura de 35,2 °C, FC 70 latidos por minuto, FR 26/minuto, TA. 90/60, glucemia capilar 55 mg/dl.

Además de abrigarla, asegurar vía aérea, colocar oxígeno y monitoreo de signos vitales. ¿Cuáles son las conductas iniciales más apropiadas? **(Marque hasta 3 opciones)**

- ☒ a) Solicitar medio interno, glucemia y medición de etanol en sangre.
- ☒ b) Indicar expansión con solución fisiológica.
- ☒ c) Indicar SNG, hidratación EV con solución dextrosada. **KILLER**
- ☐ d) Solicitar pesquisa de tóxicos en orina.
- ☐ e) Solicitar TAC de cráneo y cerebro.
- ☐ f) Administrar carbón activado.
- ☐ g) Realizar lavado gástrico con solución fisiológica fría.
- ☐ h) Administrar Tiamina.

4-6. Emanuel.

Emanuel es un adolescente de 13 años, sano, con esquema de vacunación completo acorde a su edad y con rendimiento escolar satisfactorio. Acude a la consulta acompañado por sus padres por presentar agrandamiento de la mama izquierda de 2 cm, manifestando leve dolor a nivel de la mamila, cuadro que hizo su aparición aproximadamente una semana antes de la visita médica. Niega la existencia de otros síntomas. Más allá del hallazgo referido por Emanuel, el resto del examen físico no muestra datos a destacar. Los valores de presión arterial son normales. La evaluación de la maduración física arroja un estadio II-III de Tanner para genitales y vello pubiano.

Ante esta situación, Ud decide:

(Marque hasta 3 opciones)

- a) Derivar a cirugía mamaria.
- b) Informar que se trata de un evento transitorio.
- c) Mediar con antiestrógenos.
- d) Solicitar mamografía.
- e) Solicitar ecografía mamaria.
- f) Continuar con los controles habituales.
- g) Solicitar determinación de LH, FSH y testosterona.
- h) Mediar con ibuprofeno en caso de dolor.

5-1. Mía.

Usted se encuentra de guardia en un sanatorio de CABA y llega una paciente que ha sido controlada adecuadamente durante el embarazo confirmándose que el mismo se encuentra a término, según última ecografía: 40 semanas de gestación.

La madre presenta un buen trabajo de parto no observándose situaciones de riesgo.

Luego del nacimiento de Mía, ¿cuáles son las primeras acciones a realizar?

(Marque hasta 3 opciones)

- a) Clamper inmediatamente el cordón umbilical.
- b) Evaluar los parámetros del test de Apgar.
- c) Realizar el examen clínico del recién nacido.
- d) Aplicar la vacuna BCG.
- e) Colocar al recién nacido en contacto con su madre.
- f) Realizar la pesquisa neonatal.
- g) Aplicar la vacuna contra la hepatitis B y la vitamina K.
- h) Dejar al recién nacido en observación en Neonatología.

Ud. ha finalizado el examen, por favor pase las respuestas a la grilla.

GRILLA DE RESPUESTAS CORRECTAS

P	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	5			E0	2		3			
2		E0		4	2			4		
3	4			4	2			E0		
4		4			3		E0	3		
5	4		4	E0		2				
6		3			4	E0	3			
7		4	3	3		E0				
8		4	E0	3	3					
9	E0	4		3			3			
10	2		4		E0		4			
11		4		3		3	E0			
12	3		E0			4		3		
13	4		E0		3	3				
14	3			4	E0		3			
15	4	E0				3		3		
16		E0		4	4		2			
17	4		2	4				E0		
18	E0			2	4			4		
19		3		E0	4		3			
20		2			E0	4	4			
21		4	4		E0	2				
22	4	4		E0	2					
23	3		4	3						
24		4	E0			3		3		
25		3			4		3	E0		